ICS 11.020
C 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 33415—2016

针灸异常情况处理

Handling methods for acupuncture abnormal conditions

2016-12-30 发布 2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出并归口。

本标准起草单位：天津中医药大学。

本标准主要起草人：郭义、何文菊、陈泽林、史丽萍、翟伟、任秋兰、赵雪、谭亚芹、杨毅、刘延祥、王娟、杨会杰、孔凡亮、马昕婷、刘亮。

针灸异常情况处理

1 范围

本标准规定了针灸异常情况的术语和定义、不良现象、处理方法。

本标准适用于针灸异常情况的处理操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 299—2008 乙型病毒性肝炎诊断标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

针灸异常情况 acupuncture abnormal condition

在针灸治疗过程中，由于术者操作不当或患者自身原因，发生的与治疗目的不相符合的不良现象。

3.2

晕针 fainting during acupuncture

在针刺过程中，患者突然出现头晕目眩、面色苍白、心慌气短、倦怠乏力、恶心欲呕、身出冷汗，甚至晕厥的现象。

3.3

滞针 sticking of needle

在行针或留针过程中，医者感觉针下滞涩，提插、捻转、出针均感困难，患者感觉疼痛的现象。

3.4

弯针 bending of needle

将针刺入腧穴后，针身在体内形成弯曲的现象。

3.5

折针 breaking of needle

在针刺过程中针身折断在肌体内的现象。

3.6

后遗感 lingering after acupuncture

出针后，针刺局部仍遗留酸、胀、疼痛、麻木等不适的感觉。

3.7

气胸 pneumothorax

针刺时刺破胸膜壁层或脏层，导致气体进入胸膜腔，引起咳嗽、呼吸困难等症状。

4 不良现象

4.1 常见的针灸不良现象包括:晕针,滞针,弯针,折针,后遗感,气胸、烫伤,感染,过敏,针灸致神经、血管及脏器损伤等。引起针灸异常情况的原因参见附录A。

4.2 晕针根据症状出现的时间可分为即时晕针和延迟晕针。即时晕针发生在针刺治疗过程中;延迟晕针发生在针刺治疗结束后,其症状可出现在取针后数分钟乃至更长时间。

4.3 晕针程度可分为轻度晕针和重度晕针。轻度晕针是指患者突然出现头晕目眩、面色苍白、心慌气短、恶心欲呕、身出冷汗,脉象沉细;重度晕针在轻度晕针的基础上出现四肢厥冷、神志昏迷、二便失禁、不省人事、脉微欲绝等。

5 处理方法

5.1 晕针的处理方法

5.1.1 轻度晕针的处理

立即停止针刺,将针全部起出,使患者平卧,头部稍低,注意通风和保暖,给饮温水或糖水,静卧片刻至症状消失。

5.1.2 重度晕针的处理

在上述处理基础上,针刺人中、素髎、内关、足三里,或灸百会、气海、关元等穴。必要时配合其他急救措施。病情缓解后,适当休息。

5.2 滞针的处理方法

因患者精神紧张者,做好解释工作,消除紧张情绪,循按拍打滞针局部,或适当延长留针时间,缓解肌肉紧张状态。

因单向捻转过度,向相反方向回捻,并用刮柄、弹柄法。

因患者移动体位引起者,嘱患者慢慢恢复原来的体位。

必要时可在滞针远端浅刺1针。不强力硬拔。

5.3 弯针的处理方法

出现弯针后,不再行提插、捻转等手法。

因患者移动体位所致,嘱患者慢慢恢复原来的体位。

针身轻微弯曲,将针身慢慢退出;弯曲角度较大,先使局部的组织皮肤放松,再顺着弯曲的方向将针退出。针身弯曲不止一处,观察针身弯曲的方向,分段逐渐退出。

不强力硬拔。

5.4 折针的处理方法

嘱患者不要移动体位,以防折针向肌肉深层陷入。

断端露在体表,用手指或镊子将针起出;断端与皮肤相平,用拇、食二指顺针身方向挤压针孔两旁,使断针暴露体外,持镊子将针取出;断端全部陷入肌肉,请外科会诊。

5.5 后遗感的处理方法

轻者在局部上下循经按压、热敷或按摩;重者局部加以艾灸。

必要时可口服营养神经类药物。

5.6 气胸处理方法

及时出针。无明显自觉症状，宜卧床休息，对症处理。症状较重，立即急救处理，并转外科诊治。

5.7 烫伤的处理方法

迅速脱离致伤源。立即用凉水湿敷或浸泡伤区。注意创面清洁和干燥，如有水疱形成不必处理，大水疱可用消毒针抽吸，局部保持清洁干燥，外用烫伤膏等药物，并以纱布包敷。

必要时可口服抗生素预防感染。

5.8 局部化脓性感染的处理

嘱患者休息少动，抬高患肢。不要挤压患部。可外敷抗菌消炎软膏，适当应用消炎止痛、清热解毒的中西药物，配合理疗热敷。

5.9 过敏的处理方法

针刺、艾灸、穴位注射或使用蜂针过程中出现不良过敏反应时，立即停止治疗。有局部或全身过敏性皮疹者，用抗组胺、维生素等药物，多饮水。

必要时可适当应用皮质类激素。

5.10 针刺致神经损伤的处理方法

5.10.1 中枢神经损伤

针刺直接或间接导致的脑出血、蛛网膜下腔出血、小脑及延髓、脊髓等中枢神经损伤，一旦发现，立即转相关科室救治。

5.10.2 周围神经损伤

针刺造成周围神经包括颅神经和脊神经损伤时，停止针刺，热敷理疗，配合局部按摩，加强功能锻炼。

5.11 针灸致血管损伤的处理方法

5.11.1 浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔 1 min～2 min 即可。

5.11.2 较大血肿，首先应予冷敷，出血停止 24 h 后可改用热敷。

5.11.3 损伤四肢较大的动脉，出血不止者，在针孔处加压包扎。

5.11.4 对体腔内的出血，症状表现较轻，在严密的观察下选用药物止血。出血量较大，患者出现明显的休克症状，在止血的同时，进行抗休克治疗。

5.12 针刺致脏器损伤的处理方法

5.12.1 针刺导致心脏、胃、脾、肝、肾、肠、膀胱等脏器损伤时，在严密观察下，如病情不再发展，可卧床休息。

5.12.2 若情况严重时，立即转外科治疗。

附　录　A
（资料性附录）
针灸异常情况发生的原因

A.1　术者的原因

A.1.1　守神不强

术者在治疗过程中守神不够、注意力不集中、疏忽大意，是造成针灸异常情况发生的一个重要原因。在施针过程中，术者应集中注意力，细心操作，准确取穴，体会针下变化，行针有度，以确保疗效。

A.1.2　消毒不严

术者手部、针具、穴区的消毒不严都有导致感染的可能。重复使用针具的消毒容易被忽视，应引起注意。还包括针刺后针孔的护理、烫伤及拔罐起泡后的护理。

A.1.3　操作不当

术者在针灸治疗过程中，取穴不准、针刺过深或进针方向错误、手法操作不当、对人体解剖不熟悉均可造成针灸异常情况的发生。

A.1.4　针具使用不当

针具由于反复使用已有裂痕、粗钝、毛刺，术者在针灸操作前忽视检视，在再次使用时极易造成疼痛、出血、感染、折针及组织器官损伤等情况发生。另外，穴位注射选择药物浓度过高或刺激性较大，常易导致组织损伤。

A.2　患者的原因

A.2.1　心理因素

紧张、恐惧或情绪过度激动，容易晕针，特别是初诊患者。

A.2.2　生理因素

饥饿、疲劳等，是导致晕针常见的原因之一。

A.2.3　体质因素

过敏体质者易对穴位注射的药物、艾灸及针灸针发生过敏反应。

A.2.4　病理因素

脏器因病变而出现体积增大，易被针具误伤。血友病患者，针刺时极易导致出血。

A.2.5 其他因素

主要是不合作因素，少数患者在留针过程中，任意变换体位，导致滞针、折针的发生。